

Osteoporose

Osteoporose fører til redusert bentetthet og økt risiko for brudd, spesielt i ryggvirvler, hofter og håndledd. Sykdommen utvikler seg ofte uten symptomer før et brudd oppstår. Risikofaktorer inkluderer høy alder, kjønn (kvinner er mer utsatt), arvelighet, lav kroppsvekt, inaktivitet, røyking og lavt inntak av kalsium og vitamin D.

Ikke-medikamentell behandling for å styrke skjelettet og redusere risikoen for brudd anbefales:

- **Kalsiumrik kost:** Meieriprodukter, grønne bladgrønnsaker, nøtter og fisk med bein er gode kilder. Tilskudd anbefales året rundt.
- **Vitamin D:** Viktig for kalsiumopptaket. Tilskudd anbefales året rundt.
- **Fysisk aktivitet:** Regelmessig trening er avgjørende for å bevare beinmassen og forebygge fall.
 - **Vektbærende trening** som gåturer, dans, jogging og trappetrening styrker skjelettet.
 - **Styrketrening** med vekt eller strikker hjelper til med å bygge muskler og støtte skjelettet.
 - **Balanseøvelser** som tai chi, yoga eller stå på ett bein kan redusere risikoen for fall.
- **Fallforebygging:** Fall er en av de største risikofaktorene for brudd ved osteoporose. For å redusere risikoen for fall bør pasienter:
 - Ha godt fottøy med sklisikre såler.
 - Fjerne løse tepper og ledninger i hjemmet.
 - Sørge for god belysning, spesielt i trapper og ganger.
 - Bruke håndtak og støtte i dusj og ved toalettet om nødvendig.

Medikamentell behandling Dersom risikoen for brudd er høy, kan medisiner være nødvendig:

- **Bisfosfonater** (f.eks. alendronat, risedronat): Reduserer nedbrytningen av bein og styrker skjelettet.
- **Denosumab:** Et biologisk legemiddel som hemmer beinnedbrytning.

Årlig oppfølging og kontroller For å sikre optimal behandling og oppfølging bør pasienter med osteoporose huske:

- **Årskontroll hos lege:** Blodprøver for å sjekke kalsium- og vitamin D-nivåer, samt vurdering av behandlingsrespons (egen blodprøve).
- **Vurdering av ny bentetthetsmåling:** Anbefales hvert 2.-5. år avhengig av risikofaktorer og behandlingseffekt.
- **Gjennomgang av medisiner:** Vurdering av nytte og eventuelle bivirkninger av osteoporosemedisiner.